

53 - 01-Révision séméiologie maxillo-faciale (Teams) - Pr. MANSOURI

Très bien, donc la limitation de l'ouverture buccale est par définition définie quand elle est inférieure à 30 mm chez l'adulte et inférieure à 20 mm chez l'enfant. C'est clair? C'est ça, c'est comme ça que j'appuie sur le curseur ou pas? Est-ce que je dois appuyer? Très bien. Madame, s'il vous plaît.

Oui, allez-y, je vous écoute. Si l'ouverture buccale est de 3 cm, est-ce que c'est pathologique? Oui, 3 cm n'est pas normal. Donc moi, la question, je vais mettre inférieure.

Je vais vous poser la question exactement de ce qui est écrit sur votre code. Une ouverture buccale inférieure à 30 mm chez l'adulte, pas chez l'enfant, est limitée. La limitation est définie par inférieure à 30 mm chez l'adulte et inférieure à 20 mm chez l'enfant.

C'est clair? Je ne vous poserai pas de piège. Et nous avons les causes de la limitation de l'ouverture buccale. Donc vous, je crois que vous avez fait l'anatomie et donc une ouverture buccale va être limitée quand il y a un problème au niveau de l'appareil manducateur.

Est-ce que c'est oui ou non? Vous êtes d'accord, les étudiants, que l'ouverture buccale sera limitée quand l'anatomie de l'articulation n'est pas normale? C'est clair? Ou bien les muscles masticateurs. Si les muscles ne marchent pas, il n'y aura pas d'ouverture buccale. Et si l'articulation est lésée ou soudée, bien sûr, il y aura limitation de l'ouverture buccale.

Est-ce clair, les étudiants? Dites-moi. Répondez. J'attends la réponse.

Oui, bien sûr. Donc les causes, on va les classer en deux causes. Il y a les limitations de l'ouverture buccale passagère et il y a les limitations de l'ouverture buccale définitive, ce qu'on appelle aussi constriction permanente de la mâchoire.

Donc nous avons des limitations de l'ouverture buccale passagère et les limitations de l'ouverture buccale définitive ou permanente, ce sont les constrictions de la mâchoire. Je vais vous montrer ce que c'est. Alors les passagères, elles peuvent être d'origine musculaire, qui ont par contre fracture musculaire.

Et les causes, ça peut être une cause traumatique, tumorale, infectieuse ou fonctionnelle. Ici sur l'image, vous allez regarder, là c'est un patient qui a une fracture mandibulaire. Donc ça va être une fracture au niveau de l'articulation temporo-mandibulaire ou bien la branche montante où il y a le muscle masséteur ou ptérygoïdien ou bien une fracture qui est au regard du muscle temporal.

Donc tout ce qui est fracture au regard de l'appareil manducateur va entraîner une limitation de l'ouverture buccale. Et regardez-le, il a du mal à ouvrir la bouche correctement parce qu'il a une

fracture mandibulaire. Donc parmi les causes passagères des limitations de l'ouverture buccale, c'est les causes traumatiques.

Parmi les causes passagères, ce sont les infections. Et là, j'insiste sur la cellulite faciale. Là, voilà l'infection par infection dentaire.

Ce sont les causes infectieuses. Et on voit ici, bien sûr, ce patient qui a une tuméfaction de la joue et qui a une infection d'origine dentaire qu'on appelle cellulite. La cellulite, c'est l'inflammation des tissus cellulogresseux de la face.

Et donc ça entraîne, par irritation des muscles massétères et ptérigoudiens, donc des muscles masticateurs, une limitation de l'ouverture buccale. Donc ce qu'il faut retenir pour vous, il y a les limitations de l'ouverture passagère, dont le trismus qu'on appelle le trismus. Par contracture musculaire, les causes sont traumatisme, tumeur, infection et les causes fonctionnelles.

Mais reprenez beaucoup traumatisme, tumeur et infection. Traumatisme, tumeur et infection. Et nous avons les constrictions permanentes de la mâchoire.

Regardez cette image. C'est une personne qui n'arrive pas à ouvrir sa bouche et l'ouverture buccale est égale à zéro. Et on va voir la cause.

C'est une soudure de l'articulation temporomandibulaire. C'est une personne qui a eu une fracture pendant l'enfance et qui a eu une soudure de l'articulation temporomandibulaire. L'articulation a collé, il n'y a plus d'espace articulaire.

Et donc, on va revenir à la première image de notre appel à l'orthopédie. Au lieu qu'il y ait un espace articulaire et un disque, l'os s'est collé, l'os temporal et l'os mandibulaire se sont collés l'un à l'autre. Et donc, on arrive à cette soudure de l'articulation temporomandibulaire qui va donner une ouverture buccale à zéro.

C'est une constriction permanente de la mâchoire. Et cette constriction permanente, je m'excuse parce que là c'est une diapo qui est refaite. La cause, c'est ce qu'on appelle l'ankylose temporomandibulaire.

Le mot ankylose veut dire soudure. Ankylose, notez-le pour que vous sachiez lire ça. C'est l'ankylose temporomandibulaire.

Donc, parmi les causes de constriction permanente de la mâchoire d'origine articulaire, c'est l'ankylose temporomandibulaire. Vous voulez poser une question les étudiants ? Donc, si on veut résumer tout cela, on a dit les causes passagères, c'est soit par traumatisme, par tumeur, par infection et fonctionnelle. Et parmi les causes de constriction permanente ou définitive, c'est l'ankylose temporomandibulaire.

C'est la cause traumatique, mais ça peut être d'origine infectieuse, d'origine tumorale, d'origine

rheumatizmale ou bien par syndrome malformatif. Est-ce que vous avez saisi les étudiants ? Répondez-moi oui ou non. Très bien.

Donc, nous passons à l'occlusion dentaire. On vous a fait l'anatomie des dents, je crois, et on vous a expliqué certainement que les dents se mettent les unes sur les autres. Ça s'appelle l'occlusion dentaire.

Donc, vous voyez sur cette image comment les dents supérieures s'interposent sur les dents inférieures. Vous le voyez, comment elles s'interposent. C'est l'occlusion dentaire normale.

Donc, elle traduit les relations stables et fonctionnelles de dents à dents, selon la classification de ce monsieur qui s'appelle Angle. Donc, elle détermine ce qu'on appelle l'articulé dentaire, comme l'articulation. L'articulé, c'est comme l'articulé, mais comme les dents, quand elles s'interposent les unes sur les autres, on n'ose pas les appeler articulation, on les appelle articulés.

C'est-à-dire comment les dents s'articulent les unes sur les autres. Donc, c'est l'ensemble des contacts établis entre les dents du maxillaire et les dents de la mandibule. Donc là, j'ai mis quatre croix.

Si je pose une question, vous devez être capable de répondre. Qu'est-ce que c'est l'articulé dentaire ? C'est l'ensemble des contacts établis entre les dents du maxillaire et les dents de la mandibule. Est-ce clair ? Est-ce clair les étudiants ? Ce qui est au milieu, c'est l'articulé dentaire, ensemble des contacts établis entre les dents du maxillaire et les dents de la mandibule.

Si je pose un QCM là-dessus, je mets l'articulé dentaire, c'est l'ensemble des contacts entre les surfaces articulaires. Est-ce que c'est juste ? Si je mets articulé dentaire comme définition, première réponse du QCM, c'est l'ensemble des contacts. Très bien, très bien Nabil, c'est faux.

Et si je mets, c'est l'ensemble des contacts entre les os de la face. C'est faux, bien sûr. Donc la réponse, c'est l'ensemble des contacts établis entre les dents du maxillaire et les dents de la mandibule.

Je peux mettre tout simplement, c'est le contact, il traduit le contact entre les dents maxillaire et les dents de la mandibule, tout simplement. Et ça s'appelle articulé dentaire. Or, pas tout le monde, si vous le remarquez dans la société, qui a des dents supérieures qui se posent sur les dents inférieures.

Vous le savez ça, il y a des gens qui ont des dents un petit peu en avant, des dents un petit peu en arrière, et donc qui ont un problème et qui vont chez l'orthodontiste pour aligner leurs dents. Vous savez ça ? Est-ce clair ? Oui ou non ? Vous savez qu'il y a des gens qui ont des anomalies d'articulé dentaire. C'est pour cela qu'ils vont chez l'orthodontiste.

Donc, quelles sont ces anomalies ? Eh bien, selon la classification d'angle, on va commencer par 3. La classe 3, c'est quand la mandibule est en avant. Regardez les dents du bas, elles sont en

avant par rapport aux dents du haut. Dents du bas en avant par rapport aux dents du haut.

La classe 2, donc il y a des gens qui ont, quand vous les voyez, ils ont la mâchoire en avant. Regardez l'image ici. Et il y a des gens le contraire, qui ont le menton en arrière et qui ont le maxillaire en avant.

Vous connaissez ça ? Des gens qui ont la mâchoire proéminente supérieure. C'est la classe 2. C'est un décalage vers l'avant des dents supérieures par rapport aux dents inférieures. C'est un décalage vers l'avant des dents supérieures par rapport aux dents inférieures.

Ou bien, c'est un décalage vers l'arrière des dents inférieures par rapport aux dents supérieures. Est-ce clair ? Est-ce clair, les étudiants ? Très bien, Imane. Très bien, Imane.

Très bien, Abdelbaste. Donc, en fait, le type le plus fréquent, c'est ce qu'on a vu sur l'image. C'est quand les dents supérieures dépassent un tout petit peu les dents inférieures de 2 mm.

Là, quand vous allez chez l'orthodontiste et vous alignez les dents, c'est pour arriver à ça. Arriver à la classe 1 dentaire d'Angleterre, c'est le type le plus fréquent. Alignement des points interincisifs, des bords incisifs.

Nous voilà ici, on a un bon alignement. Et on a un recouvrement des incisives mandibulaires par rapport aux incisives maxillaires. Regardez-moi ça.

Donc, la dent supérieure recouvre un tout petit peu les dents inférieures et qui sont bien centrées. Alors que la classe 2, nous avons les dents supérieures qui sont en avant. La classe 3, nous avons les dents inférieures qui sont en avant.

Et ça définit le profil de la face. Est-ce que vous avez saisi ? Donc moi, si je pose un petit QCM classe 2, c'est décalage vers l'avant des dents supérieures. Et si je pose une question, le type le plus fréquent, classe 1, c'est alignement des dents et recouvrement des incisives mandibulaires par rapport aux incisives maxillaires.

S'il vous plaît, madame. Oui, mon fils. Classe 1, c'est le normal.

L'aspect ? Classe 1, c'est le normal. Je n'aime pas qu'on dise normal. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on dira le plus fréquent.

Il y a des gens qui sont nés avec une mâchoire supérieure en avant. C'est leur profil familial, c'est génétique. Ce n'est pas dysmorphique, ce n'est pas de la malformation.

Je vais vous expliquer pourquoi. Vous devez le savoir maintenant. Vous allez être médecin.

Chez nous, en Afrique, on a tendance à la biproale violée. Aux dents supérieures et inférieures qui sont en avant un peu, qui se nidrettent. C'est l'aspect à nous, c'est notre profil, c'est notre

race.

Et donc, nous ne pouvons pas dire normal. On dit le type le plus fréquent. Mais les gens, en Asie par exemple, il y a ce qu'on appelle profil transfacial.

Les dents sont un peu reculées en arrière. Les dents du haut et du bas. Parce que le profil facial et l'aspect morphologique d'un visage, il dépend des races aussi.

Donc ici, c'est les repères et les références de la race caucasienne européenne. Nous, en Afrique, peut-être que ce n'est pas le profil le plus fréquent chez nous. Du moins, nous, au Maroc, on a fait une étude de recherche là-dessus.

Nous avons les dents du haut et du bas qui avancent un peu vers l'avant. Parce qu'on est un mélange afro-maghrébin. Donc, on est mélangé avec l'Afrique.

Entre l'Afrique, le caucasien et le berbère. Et donc là, on ne parle pas de pathologie du tout. C'est une classification.

Oui et même. Ce n'est pas pathologique. Ce n'est pas maladif.

C'est un profil habituel. Mais les gens, on ne l'aime pas. Et sur le plan fonctionnel, ça gêne.

On fait de l'orthodontie. C'est clair ? Donc, excusez-moi. Toujours, je n'arrive pas à sortir.

Alors, quelles sont les anomalies ? C'est-à-dire ce qui est pathologique. Là, on est dans le pathologique. Il y a d'abord la supraclusion.

Regardez-moi ici. Est-ce que vous pouvez comparer cet articulé par rapport à cet articulé ? Regardez. Là, nous avons les dents du haut qui sont enfoncées dans le vestibule inférieur.

Et les dents du bas qui sont enfoncées dans le vestibule supérieur. Vous avez vu ? Donc ici, on parle de supraclusion. Supraocclusion.

C'est-à-dire des dents qui sont trop basses, trop enfoncées dans le vestibule. Si on revient ici, on a dit 2 mm. Un recouvrement uniquement de 2 mm.

Mais là, nous avons la supraclusion avec une couverture trop basse des incisives. L'infraclusion, c'est quand vous avez le contraire, avec même une béance. Vous pouvez même avoir une béance.

C'est-à-dire que les dents ne peuvent pas se toucher. Et nous pouvons avoir ce qu'on appelle un articulé croisé, comme ici. Regardez l'incisive inférieure.

Le point interincisif inférieur et supérieur ne se regarde pas. Donc, on peut avoir un articulé qui se croise. Est-ce clair ? Donc, les anomalies verticales à retenir, la supraclusion, l'infraclusion et

l'articulé croisé.

Est-ce clair ? Est-ce clair, les étudiants ? Non. Si Benafdil me dit non, il a raison. Or, les anomalies dans le sens vertical, du haut vers le bas, les anomalies de la position d'une manière verticale, c'est-à-dire crânio-cordale, de haut vers le bas, les dents peuvent être normales.

Voilà normal. C'est ça. Les dents supérieures recouvrent, c'est le type le plus fréquent, recouvrent avec deux millimètres les dents du bas.

Mais les dents peuvent être très en bas vers le vestibule. Elles s'enfoncent vers le vestibule. C'est la supraclusion.

Et elles peuvent ne pas se toucher. C'est l'infraclusion. Non, on ne peut pas regarder l'infraclusion.

Par définition, les dents sont trop basses. Les dents supérieures sont trop basses par rapport aux dents inférieures. Elles les recouvrent complètement.

Ça, c'est infra, inférieure. Et les supras, regardez ici, elles ne se touchent même pas. C'est le contraire.

Vous avez vu ? Est-ce clair ? Et la deuxième anomalie, c'est ce qu'on appelle la pro-alvéolie et la rétro-alvéolie. C'est dans le sens anteropostérieur. L'os alvéolaire, vous l'avez vu, en anatomie mandibulaire, c'est l'os qui porte les dents, qui est né et qui disparaît avec les dents.

Donc, on peut avoir les dents avec l'os alvéolaire qui est en avant. Ça s'appelle pro-alvéolie. Et quand c'est la mandibule qui est en avant, en arrière, c'est la rétro-alvéolie.

Nous avons la bi-pro-alvéolie. La bi-pro-alvéolie, c'est ce qui fréquente chez nous en Afrique quand on a les deux arcades qui sont en avant. Malheureusement, je ne vous ai pas mis la photo.

Donc, nous avons les anomalies verticales, la supraclusion, l'infraclusion et l'articulé croisé. Et nous avons les anomalies de l'articulé dentaire, la pro-alvéolie, la rétro-alvéolie et la bi-pro-alvéolie. C'est bon, les étudiants ? Mais dans ce cours, j'aime bien la définition de l'articulé dentaire.

Est-ce que vous l'avez retenu, les étudiants ? Très bien. Donc, on passe aux allergies faciales. Vous savez que, comme partout, on a des douleurs.

La douleur faciale est une douleur comme les autres douleurs. La douleur abdominale, la douleur la céphalée, je pense que vous l'avez eu au cours, comme les douleurs du genou, la face aussi, il y a des douleurs. Et donc, parmi ces douleurs, l'algie faciale la plus fréquente, c'est celle que je vais très vite aller directement vers cette algie faciale.

C'est d'abord les étiologies d'une manière générale. Je tiens à ce que vous le sachiez. C'est les algies faciales neurogènes, vasculaires, d'origine stomatologique ou éryléoophthalmologique, algies

faciales des articulations temporomandibulaires et idiopathiques.

Alors, ça veut dire quoi, neurogène ? Quel est le nerf qui est responsable de la sensibilité au niveau de la face ? Dites-moi vite fait, les étudiants. Qui est le nerf qui est responsable de la sensibilité ? Très bien. Excellent.

Donc, on peut avoir le 5. Très bien. Le 7, non. Il ne faut pas faire la confusion entre le 7 et le 5. Le 5, c'est un nerf de la sensibilité faciale avec les territoires sensibles.

Et le 7, c'est le facial qui inhère les muscles fessiers. Le 7, il donne la sensibilité de la face. Le 5, mais aussi très bien calé, la motricité, les muscles masticateurs.

Donc là, les algies faciales d'origine neurogène, ce sont les problèmes liés au nerf trijumeaux. Et quand on revient à l'anatomie du nerf trijumeaux, le voilà. Donc, il provient du cerveau.

Ganglion de Gasser, 5.1, 5.2, 5.3. Vous connaissez tout ça. Donc, s'il y a une tumeur qui comprime le ganglion de Gasser, on peut avoir une douleur. Quand il y a une tumeur au niveau cérébral, on peut avoir une douleur.

Quand on a un problème ici par fracture, par exemple, au niveau de la mâchoire supérieure ou inférieure, ou bien au niveau frontal, on peut avoir une douleur. Donc, on dit que ça peut être l'origine neurogène, quelle qu'il soit la cause, sur tout le trajet du nerf. Très bien.

Très bien, les étudiants. Excellent. D'où l'intérêt de l'examen de la sensibilité faciale.

Très bien, Praline. Donc, nous avons les allergies d'origine vasculaire. Vous connaissez la vascularisation de la face ? Bien sûr, ça vient de la carotide externe.

Si vous avez un problème, quelque chose qui comprime l'artère temporale superficielle, on va avoir une douleur frontale, temporo-frontale, puisque l'artère donne une branche à la région frontale et une branche à la région temporale. Et donc, si elle se comprime, elle va donner une douleur dans son territoire. Donc, nous avons des allergies faciales d'origine vasculaire.

Si on a un problème au niveau de l'artère faciale, qui irrigue la joue, le nez, on va avoir une douleur au niveau de la joue et qui correspond au territoire de vascularisation de la face. Oui, donc, nous pouvons avoir aussi d'origine stomatologique. Ça, vous le savez, d'origine dentaire.

Stomatologique, ça vient de stomodermes, de la cavité buccale et des dents. Donc, stomatologique, c'est dentaire. Je crois sûrement que parmi vous, il y a certains qui ont eu une douleur dentaire.

Donc, une allergie faciale d'origine dentaire. Elle peut être d'origine ORL. Une angine fait mal.

Bien sûr, une otite. L'otite fait très très mal. On peut avoir l'ophtalmologie.

Un problème au niveau de l'œil peut donner une douleur. Donc, nous avons les allergies faciales d'origine neurogène, d'origine musculaire, d'origine stomatologique ORL et ophtalmo et nous avons les articulations temporomandibulaires, comme le genou. Quand il y a un rhumatisme de l'articulation ou une fracture, elle peut faire mal.

Et nous avons les causes qui sont idiopathiques sans explication. Donc là, on peut avoir un QCM là-dessus. Quels sont les cinq groupes d'allergies faciales ? Neurogène, vasculaire, stomatologique ORL, ophtalmologique et articulation temporomandibulaire.

Est-ce clair les étudiants ? Est-ce clair ? Très bien. Ne me dites pas que je ne l'ai pas dit. Bien.

Parmi les causes, il y a la névralgie essentielle ou tic de trousseau. Cette névralgie, regardez cette dame comment elle tient son front. Celle-là, elle tient la joue.

La région temporale, la joue. Et l'autre, la région basse du visage. Donc, c'est l'un des territoires sensitifs de la face.

Des particularités, c'est une douleur brutale. À décharge, pardon, excusez-moi. Voilà.

Une douleur chez la femme de 50 ans. Douleur brutale à type de décharge électrique qui siège dans le territoire sensitif du trijumeau. Soit frontal, soit jugale, soit la biomentonnière.

Elle est déclenchée par les zones gâchettes. Voilà les zones gâchettes. La personne peut mettre son doigt sur le front, sur la joue, près du nez, la lèvre, au niveau paramentonnier et ça peut créer une décharge de douleur et des crises douloureuses.

Et ça peut évoluer vers un état de mal possible. Donc, la névralgie essentielle au tic de trousseau. La névralgie essentielle au tic de trousseau est une névralgie très fréquente chez la femme de 50 ans.

Elle est brutale à type de décharge électrique et qui a un moment d'emblée maximale de durée brève qui siège dans le territoire sensitif atteint du trijumeau et qui est déclenchée au niveau des zones gâchettes et qui évolue par crise. Donc là, je ne veux rien savoir. C'est aussi un QCM que vous devez connaître.

Est-ce clair, les étudiants ? D'ailleurs, moi, à votre place, je peux mettre un tableau et je mettrai toutes les douleurs ensemble. La colique néphrétique, la colique hépatique, la douleur angineuse du cœur, la névralgie faciale essentielle et je mettrai sur ma colonne des comparaisons. Est-ce que c'est l'homme ou la femme ? Est-ce que c'est une douleur brutale ? Alors, les zones gâchettes.

Il y a un collègue qui me pose la question sur la zone gâchette. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une gâchette d'abord ? Rappelez-vous des films Cowboy. Ils ont le pistolet à la main.

Sur quoi ils appuient ? Sur la gâchette, n'est-ce pas ? Ils appuient sur la gâchette. Il appuie sur ce petit bout métallique sur lequel il met le doigt et la cartouche sort. C'est comme une gâchette.

L'être humain met son doigt sur un point supra-orbitaire, un point infra-orbitaire ou bien un nasolabial ou bien paramentonné à la sortie d'une aire mandibulaire, donc le 5-3. Dès qu'il appuie sur cette zone, il risque de déclencher, comme une gâchette, comme une cartouche, la douleur. Et bien sûr, c'est ce que vous voyez sur la photo.

Ce sont des douleurs terribles. Est-ce clair ? Bon, il y a... Madame ? Oui ? Est-ce qu'il ne va pas survenir ? Pardon ? Est-ce qu'il... ? Est-ce qu'il ne va pas survenir ? Est-ce qu'il ne va pas survenir ? Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème.

Dites-le, je vous écoute. La question était, est-ce que c'est les bras algifarciens ? Est-ce qu'il ne va pas survenir chez l'homme ? Bien sûr qu'il peut survenir chez l'homme. Ça existe, mais le plus fréquent, c'est la femme.

C'est-à-dire qu'elle n'est pas exclusivement chez la femme, bien sûr, mais elle est plus fréquente chez la femme. D'accord ? Donc, il y a l'algie vasculaire de la face, c'est un autre type de douleur, mais qui est d'origine vasculaire. Elle est plutôt la panache de l'homme, mais elle est beaucoup moins fréquente.

La plus fréquente, c'est celle-là. C'est la névralgie faciale essentielle, aussi qu'il y a d'autres ressorts. Il y a ce qu'on appelle la chiquiqua.

C'est la chiquiqua. Il y a beaucoup de chiquiquas. Quand elle est au niveau frontal, c'est la chiquiqua.

Tu dis que c'est la chiquiqua, C'est l'entourage. Est-ce clair ? Bien. On va aller directement à notre cours, la colique salivaire.

J'essaie d'insister sur les choses les plus importantes. La colique salivaire, je crois que vous connaissez les coliques déjà. Non ? Vous avez vu d'autres coliques ? Dites-moi si vous avez eu d'autres coliques.

Non. Vous avez eu des coliques. Par exemple, la colique néphritique.

Très bien. Très bien. Très bien Sonia.

Donc la colique néphritique, oui. Est-ce que vous avez une idée ? Colique hépatique, bravo Imen. Nous avons la douleur angineuse, la douleur cardiaque aussi, qui est aussi l'équivalent d'une colique.

Ça veut dire quoi une colique ? Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi on l'appelle colique ? Est-ce que c'est par rapport au collant ou par rapport au canal ? Allez, mettez-moi canal ou

collant. Par rapport au canal ? Oui, très bien. Bien sûr, c'est une tension du canal.

Elle résulte d'une tension d'un canal. La tension d'un canal, canal hépatique, canal de l'urterre, c'est un canal, bien sûr. Les vaisseaux du cœur, bien sûr.

Le canal salivaire que vous avez eu en anatomie, bien sûr. Tout obstacle sur un canal ou un spasme, soit un obstacle à l'intérieur, un corps étranger, ou bien un spasme, donc une fermeture brutale, donc une constriction, une fermeture brutale, va déclencher une douleur critique. Ça s'appelle colique.

Et comme on a la colique néphritique par rapport au rein, colique hépatique par rapport au foie, on peut avoir la colique salivaire par rapport à quoi ? Au gland salivaire que vous connaissez. Et donc, on va voir ces glandes salivaires comme rappel. Les voilà, les glandes salivaires.

Regardez-moi. Il y a la glande parotide qui est drainée par le canal de Steno. La glande submandibulaire, celle-là, qui est drainée par le canal de Vartan.

Et nous avons la sublinguale qui est drainée juste sous la langue, ici. Donc, ces canaux peuvent être spasmés, peuvent être fermés et créer une colique. Cette fois-ci, la colique salivaire, elle ne va pas être lombaire ou hépatique, elle va être faciale.

Et on va la voir. Donc, la colique salivaire est une douleur critique. Donc, ça évolue par crise, comme la colique néphritique.

Au niveau submandibulaire, parotidien ou sous-mandonnier, la plus fréquente, elle résulte du spasme et de la rétention totale du canal, mais la plus fréquente, c'est la submandibulaire parlitase. Donc, regardez la projection de la parotide, la projection de la submandibulaire et de la sublinguale. Donc, c'est un symptôme fréquent qui affecte souvent le jeûne et qui est souvent au niveau submandibulaire, donc sous l'os mandibulaire, et donc au niveau de la glande submandibulaire.

Alors, là, vous devez aussi connaître la sémiologie d'une colique salivaire. Elle est de sièges submandibulaires vives, beurreuses, qu'un type de tiens raillement, irradiant vers la langue, au plancher buccal, l'oreille, qui va céder rapidement, qui va céder rapidement, et on va revenir après, au rythme par le repas. Si on veut comparer les coliques, la colique néphritique, elle siège où ? Allez, répondez vite.

Elle siège où, la colique néphritique ? Lombaire, très bien. La colique hépatique, elle siège où ? Très bien, Gatty. La colique hépatique, où est-ce qu'elle siège ? Très bien.

Non, pas hypogastrique, au niveau sous-costal et donc latéral. L'hypochondre droit, parfait, au niveau de l'hypochondre droit. La douleur angineuse, la douleur cardiaque, où est-ce qu'elle se trouve ? On est en train de faire une comparaison.

Vous avez fait la douleur angineuse du cœur ? Oui, rétrosternale, donc là, sternale, très bien, très bien. Et la colique salivaire ? Donc, si vous voulez faire un petit tableau, prenez des stylos maintenant, et faire un petit tableau, on va comparer. La douleur, la colique salivaire, elle est submandibulaire, donc elle est sous l'angle mandibulaire.

On a vu sur la photo, regardez-moi ici. Excusez-moi, voilà. Elle est submandibulaire, vive et brusque.

Toutes les coliques sont vives et brusques, hépatiques, néphritiques et tout, et actives de tiraillement irradiant vers la langue. Donc, elle, elle irradie vers la langue et le plancher buccal et l'oreille. Par exemple, la douleur angineuse, elle irradie vers le membre supérieur et vers le cou.

La douleur hépatique, elle irradie parfois vers le thorax et elle empêche de respirer. La colique néphritique, elle irradie vers la face interne de la cuisse. Elle va céder rapidement.

Mais celle-là, cette douleur, elle est rythmée avec le repas. Je sais que vous êtes très intelligents, vous comprenez pourquoi. Parce que quand on mange, on se met à sécréter de la salive, et on va revenir à l'anatomie pour comprendre très vite.

Donc là, on est en submandibulaire ou en parotidien. On mange, la glande travaille, la salive circule dans le canal, et s'il est fermé, il y a rétention et il y a douleur. Donc, elle est occasionnelle, elle est occasionnée par les repas.

C'est sa particularité. Elle est comme toutes les coliques, elle est vive, bruse, tiraillement, elle a ces irradiations, mais elle est rythmée avec les repas. Et en plus, elle s'accompagne d'un gonflement de la région submandibulaire du planché buccal qu'on appelle la hérénie salivaire.

C'est comme si la glande hérénie bombait au niveau du planché buccal, et elle aussi, elle est rythmée avec le repas. C'est normal, il y a de la salive qui coule. Un obstacle, une douleur, la glande augmente, puis après, elle se vide, cette glande, et elle disparaît.

Donc, la hérénie disparaît, le gonflement submandibulaire disparaît. Et on va voir sur les images. Voilà, au niveau du planché buccal, la tumefaction submandibulaire, et elle est aussi à l'extérieur, c'est la hérénie salivaire, c'est la glande qui se remplit de salive et qui se vide.

Et quand on fait un examen au niveau endobuccal du canal du verter en endobuccal, on peut trouver du pus à l'ostium, le voilà. Et quand on fait un palpébidigital entre l'endobuccal et l'exobuccal, on peut percevoir un corps étranger qui y incalcule, par exemple, le hajraf, le mejraf, dielle, la glande, et donc un calcul ou un lithiase qui se trouve sur le trajet du canal et qui explique la hérénie salivaire. Donc, on revient, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Il faut retenir que la colique salivaire submandibulaire est une douleur de siège submandibulaire vive, brusque, tiraillement, irradiant vers la langue et le plancher buccal et qui cède rapidement et qui est rythmée avec les repas et qui s'accompagne de la hérénie salivaire qui est un gonflement submandibulaire du

plancher buccal qui apparaît au début du repas et qui disparaît à la fin du repas avec un jet de salive sous la langue.

Est-ce que vous avez saisi les étudiants ? Ça peut faire l'effet d'un petit QCM. Est-ce clair ? Je vois Sonia qui dit oui, les autres qui se taisent, qui ne disent rien du tout, ils n'ont rien compris. Ah, la conduite, je n'ai pas le droit de vous parler de traitement.

Ici, on est en sémiologie. Mais il y a des traitements, ça dépend, on peut retirer le calcul par chirurgie, on peut donner un traitement contre la douleur, mais là, je ne traite pas les traitements, je ne vous traite que les symptômes, que la sémiologie. Très bien les étudiants.

S'il y a une collection, mais si il n'y en a pas, on peut donner aussi des antibiotiques. Très bien. Bien, donc, on avance.

Donc, vous voyez, regardez, regardez, le calcul qui a été extrait. On peut aussi extraire le calcul. Regardez.

Voilà. C'est de la taille d'un pois chiche. Regardez en sublingual, sur le trajet du canal ouvertant.

Vous avez vu le calcul, les étudiants ? Retirer de la bouche. Est-ce que vous l'avez vu ? Alors, Imane Bacali, vous avez vu ? Très bien. Donc, ce petit calcul de la taille d'un pois chiche peut obstruer le canal, peut bloquer le canal, bloquer l'évacuation de la salive et être générateur et créateur d'une colique salivaire.

Est-ce clair ? Très bien. Donc, parmi les causes de la colique salivaire, c'est la litiase salivaire, le calcul salivaire. Donc, vous n'êtes pas obligés d'apprendre tout ça par cœur, mais la litiase salivaire, si je mets un petit QCU, quelle est la cause de la colique salivaire, qu'est-ce que vous allez dire ? Litiase salivaire.

Quelle est la cause de la colique néphritique ? C'est la litiase rénale. Quelle est la cause de la colique hépatique ? C'est la litiase des voies biliaires. Les calculs proviennent de la composante chimique de la salive.

Par exemple, dans le cas de la colique salivaire, vous savez qu'il y a des concrétions calciques minuscules, des minéraux, qui, suite à des infections à répétition ou suite à un ralentissement de flux, vont s'accrocher. Regardez le calcul comment il est. C'est des micro-calculs les uns contre les autres qui vont se coller et devenir un calcul comme celui-là.

Est-ce que vous avez vu ? C'est bon, les étudiants ? Je passe sur les radios. Tout ça, on n'en a pas besoin. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que la colique salivaire est une situation fréquente en stomatologie et en chirurgie maxillofaciale qui doit conduire à une analyse anamnestique de l'interrogatoire et de l'examen clinique pour rechercher la litiase salivaire en premier lieu, sans occulter, bien sûr, la possibilité d'autre chose.

Est-ce clair, les étudiants ? On passe aux tumefactions. On a vu la limitation de l'ouverture buccale. On a vu l'occlusion.

On a vu dentaire. On a vu, avec l'articulé dentaire, bien sûr, on a vu la colique salivaire. Et maintenant, on va passer aux tumefactions aiguës de la face.

Alors, les tumefactions aiguës de la face, parmi ces tumefactions, vous avez vu d'autres tumefactions ou pas dans d'autres cours ? La tumefaction cervicale, par exemple. La tumefaction abdominale. Donc, tout ce qui... Est-ce que vous pouvez me donner une toute petite définition de ce que c'est qu'une tumefaction ? Sonia me dit d'où peuvent venir les calculs.

Moi, je crois que je l'ai expliqué. C'est la composante du liquide lui-même, que ce soit biliaire ou urinaire ou salivaire, il y a des minéraux à l'intérieur qui vont se rassembler en microcalculs. Et les microcalculs deviennent macrocalculs et puis après, il devient carrément comme une pierre.

Voilà. Sonia me dit que la tumefaction est une augmentation d'une région. Donc, la face, vous connaissez les régions de la face.

Donc, nous avons la région frontale, la région orbitaire, la région jugale, le volume. Non, ce n'est pas les proliférations cellulaires. Ça peut être une augmentation.

C'est une des causes. Non, c'est un gonflement. Le pourquoi ? On va voir les causes.

C'est clair ? On peut imaginer. On peut avoir, oui, un nodule. Oui, c'est le nodule qui est une prolifération cellulaire.

Mais une tumefaction, ça peut être liquide, ça peut être plein. Et le liquide peut être clair, serreux, et il peut être du pus. Ça peut être du sang.

Donc, ça dépend de quelles causes. Donc, quelles sont les tumefactions aiguës ? Donc, les tumefactions aiguës de la face, c'est une augmentation du volume d'une région de la face, généralement pathologique. Ça peut être infectieuse, tumorale ou traumatique.

Prolifération cellulaire, c'est tumorale. Traumatique, c'est généralement les oedèmes et les matins. Infection, c'est le pus et les oedèmes.

C'est un motif qui est fréquent en chirurgie maxillofaciale. Et donc, l'interrogatoire et la démarche diagnostique vont nous orienter vers une cause. S'il y a une notion de traumatisme, donc c'est une tumefaction d'origine traumatique.

S'il y a une manipulation dentaire, c'est une infection d'origine dentaire. S'il y a une allergie, une piqûre aux prises médicamenteuses, c'est une tumefaction d'origine allergique. Le caractère douloureux, le rapport pas avec les repas.

Si c'est une tumefaction submandibulaire qui apparaît en relation avec les repas, c'est une colique salivaire et c'est une submandibule d'origine salivaire. Les tumefactions n'aboutissent pas à la tumeur. La tumefaction, c'est la traduction de la tumeur.

Il y a une augmentation du volume sous forme d'une balle dans un visage. Elle peut s'expliquer soit par une tumeur, donc c'est une prolifération des cellules, ou bien par un liquide qui peut être du sang suite à un traumatisme, peut-être du pus par infection. Oui, c'est l'inverse.

Ça peut être une allergie, des oedèmes. On va aller voir ces tumefactions. Regardez-moi.

La tumefaction aiguë d'origine infectieuse, la plus fréquente, c'est les cellulites faciales ou cervicofaciales d'origine dentaire. Vous savez que nous, les Marocains, nous avons un problème. Nous avons un souci de caries dentaires.

On ne se brosse pas les dents. Je vais vous poser une question, les étudiants. Combien de fois vous allez vous brosser les dents par jour ? Allez, dites-moi.

Trois fois. Après, chaque repas est au moins trois fois. Et pendant combien de temps ? Pas deux, trois fois.

Combien de temps ? En minutes. Trente minutes, trois minutes, trois minutes. Trois.

Si peu, deux minutes, trois minutes. Prenez votre temps. Est-ce qu'on brosse horizontal ou vertical ? Allez-y.

Les deux. Très bien, Praline. Et essentiellement vertical.

De l'intérieur ou de l'extérieur ? Ou les deux ? De l'intérieur et de l'extérieur, bien sûr. Comme un mouvement de ballet. Vous devez verticaliser le brossage.

De l'intérieur, de l'extérieur, en horizontal et en vertical. Très bien, les étudiants. Et si on ne fait pas ça, on est exposé à la carie dentaire.

Et comme vous connaissez l'anatomie de la dent, vous savez qu'une dent comporte un canal dentaire. Et dans son canal, il y a une artère et une veine. L'artère ramène le sang et la veine ramène le sang sale.

Mais elle peut ramener l'infection. Et une dent peut tuer. Un germe, un microbe qui est ramené dans la microveine, donc dans les capillaires veineux, et qui se draine après dans la jugulaire, ça peut entraîner une infection du corps généralisée.

La carie dentaire est derrière l'aromatisme. Elle est derrière beaucoup de choses. Vous comprenez ? Vers le foie, bien sûr.

Bien sûr, l'infection du foie peut infecter tous les organes. Parce qu'une fois que ça arrive dans le

cœur droit, il va distribuer, bien sûr, l'infection dans la circulation générale. Donc, parmi les causes, on a dit, c'est une porte d'entrée très, très importante aux infections la carie dentaire.

Et regardez les tuméfactions. Vous voyez une tuméfaction paramontonnaire, une tuméfaction jugale ici, une tuméfaction jugale basse. Et qu'est-ce que vous remarquez chez tous ces patients ? Il y a quoi au niveau dentaire ? Une limitation de l'ouverture buccale.

Et on l'a dit, parmi les causes de la limitation de l'ouverture buccale, les causes infectieuses. Et donc, la cause infectieuse entraîne une irritation des muscles masticateurs et une limitation de l'ouverture buccale. Donc, parmi les causes des tuméfactions fébriles, c'est d'origine infectieuse bactérienne.

Ce sont les cellulites faciales, surtout d'origine dentaire, les adénites et la pathologie entre les glandes salivaires, telle une submandibulite. On vient de le voir. L'infection de la glande submandibulaire entraîne une tuméfaction avec syndrome infectieux.

La parotidite, c'est une tuméfaction jugale. Donc là, c'est les causes des tuméfactions d'origine infectieuse. Nous avons les causes virales comme les oreillons aussi.

Mais nous avons aussi les tuméfactions d'origine tumorale, telles les adénopathies tumorales. Et on peut aussi avoir ça, c'est les tuméfactions sans fièvre. Donc, nous avons les tuméfactions avec fièvre, d'origine infectieuse bactérienne ou virale, cellulites faciales, adénites, pathologie, mais non sans fièvre.

Il y a les tumeurs, mais il y a les traumatismes. Regardez ce patient. Qu'est-ce qu'il a ? Il a un œdème, mais c'est un œdème qui est tuméfié.

Il a du sang sous la paupière et dans l'orbite. C'est par fracture. Si on regarde le scanner, on compare gauche et droite, on voit qu'il y a un trait de fracture et l'os saigne.

Il y a une diffusion du sang au niveau de l'orbite et ça entraîne une tuméfaction orbitaire par hémorragie et par fracture faciale. Donc, si on résume les tuméfactions, on les a vues au début, on a dit qu'une tuméfaction peut être d'origine infectieuse, tumorale ou traumatique. Je ne vous entends pas.

Allez-y, parlez. Je ne vous entends pas. Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer ? Non.

Donc, la cause des tuméfactions, quand on dit infectieuse, on n'oublie jamais la cellulite faciale d'origine dentaire. Il y a les tumeurs et les traumatismes, c'est les fractures faciales. Très bien.

Alors, dites-moi, les étudiants, est-ce que vous avez des questions à poser ? Les étudiants ? Est-ce que vous avez des questions à poser ? Est-ce que je continue ? Je continue, les étudiants ? Alors, pour le reste du cours, je crois que je l'ai enregistré, mais je vais passer sur les choses importantes. C'est les anomalies de la muqueuse. Donc, comme on a vu les tuméfactions de la

face, on peut avoir les tumefactions de la bouche.

La même chose. Et nous pouvons avoir les anomalies de la pigmentation, de coloration. Regardez, on peut avoir une anomalie de coloration.

Jusqu'à votre retraite, toute coloration anormale dans l'agence IV doit faire évoquer un cancer. Est-ce clair ? C'est clair. Votre collègue me pose, s'il vous plaît.

Madame, une prise de poids, est-ce qu'elle entraîne des tumefactions ? Ça peut créer des lipomes, bien sûr, mais ça rentre dans un autre cadre. Nous, on parle des tumefactions pathologiques. Donc, les étudiants, si je vous mets un petit QCM, un patient présente une tache noire dans le vestibule supérieur.

Quelles sont les causes ? Le mélanome. Est-ce clair ? C'est clair. Vous pouvez tout oublier, mais ne m'oubliez pas le cancer.

Là, c'est une autre cause. Les pires pigmentants qui existent dans le cours, il n'y a pas de souci. Par contre, toute tache bleutée, toute tache bleutée, est une malformation.

Il y a la cyanose, bien sûr, que vous avez au cours, mais c'est une malformation. Et là, je m'arrête. Les lésions irritémateuses, nous avons les taches blanches et les taches rouges dans la bouche.

Les taches blanches et les taches rouges. Les lésions rouges, ça peut être l'inflammation, mais surtout, surtout, surtout, des états pré-cancer. Les taches, par exemple, il y a les candidoses, mais souvent, la candidose chronique de la mycose jugale, ici, c'est un carcinome presque in situ.

Et pourtant, c'est une candidose chronique. L'hyper-kératinisation, c'est-à-dire l'hyper... Alors, on va se poser la question, ça veut dire quoi cette hyper-kératinisation ? Est-ce que la mycose buccale est kératinisée ? Est-ce que l'épithélium de la mycose buccale est kératinisé d'abord ? Répondez-moi tous. Normalement, il n'y a pas de kératine.

La kératine, elle existe sur la peau. Est-ce que l'épithélium est malpégien, est pluristratifié ? Bien sûr, il est malpégien, donc il a des capacités de devenir kératinisé, puisqu'il est malpégien avec ses différentes couches. Eh bien, quand il se met à se kératiniser, et au niveau de la peau, la kératine, c'est ce qu'on enlève au bain, quand on va au bain, mais au niveau de la bouche, c'est blanc.

Au lieu que ça soit sombre, comme au niveau de la cicatrice, au niveau de la peau, au niveau de la bouche, c'est blanc comme du lait. Ce n'est pas normal d'avoir du blanc dans la bouche. C'est anormal.

Là, c'est une leucoplasie tabachique. Le tabachique, c'est un chicœur de nez fort. Jusqu'à ce

qu'elle a créé cette leucoplasie blanchante avec une hyperkératinisation.

Les hyperkératinisations peuvent créer un cancer. Ce sont des lésions précancéreuses. Le lichen plan, qui est une lésion muqueuse isolée associée, regardez comment il est en carte géographique.

C'est du blanc en carte géographique. Risque de transformation en carcinome. On revient.

Les lésions blanches en dehors de la candidose aiguë. Tout ce qui est candidose chronique blanchâtre, hyperkératinisation, pareil. Hyperkératinisation ici, pareil.

Lichen plan, pareil. Ça peut devenir un cancer. Toutes les lésions blanches en dos buccale qui persistent peuvent faire le lit à un cancer.

Est-ce que vous avez saisi ? J'ai dit toutes les lésions rouges tout à l'heure peuvent faire le lit à un cancer. Et toutes les lésions blanches peuvent faire le lit à un cancer. Parmi les autres lésions blanches, la papillomatose orale fluoride, l'hyperkératose du carcinome épidermoïde.

Tout ce qui est blanc n'est pas normal dans une bouche. Une bouche, normalement, est rouge. Elle secrète de la salive.

Elle permet de créer la salive dans la bouche. Elle permet la mastication. La mycose buccale est faite pour son travail.

Il faut qu'elle soit rouge. Quand elle devient blanche, c'est qu'elle est en train de subir une dysplasie. Une transformation au début bénigne, mais qui devient maligne après et qui peut faire le lit à un cancer.

Pour nous, en tant que praticien, il faut la biopsier, ou l'enlever, ou la surveiller, mais la lâcher comme ça dans la nature et dire au patient, non, vous n'avez rien du tout. Non, ce n'est pas rien du tout. On peut lui dire, c'est une mycose.

Mais si on traite la mycose et ça ne se traite pas, il faut biopsier pour éliminer le cancer. C'est clair. Voilà.

Les ulcérations. Alors, les ulcérations. Ici, vous risquez d'avoir un QCM sur les ulcérations.

Attachez vos ceintures, les étudiants. Toute ulcération à bord irrégulier surélevée. Irrégulier et surélevée.

Pas là. Elle est au-dessus du plan, de la lèvre, ou du palais, ou de la langue. C'est un signe de malignité.

Elle a un fond bourgeonnant et ulcéré. Regardez-moi ça. Fond bourgeonnant et ulcéré.

Et qu'il y a un saignement au contact. Quand vous mettez votre doigt, elle se met à saigner. Et qu'il y a une induration à la palpation.

Parce que normalement, la langue est molle. Les lèvres sont molles. Mais quand on trouve du tissu qui est dur, comme du cartilage, c'est une induration.

Ce n'est pas normal. C'est une prolifération tumorale. C'est un carcinome.

C'est une tumeur malignée. Donc, quels sont les signes de malignité ? QCM hyper-sortable d'une ulcération endobuccale. Ou si je pose un patient de 50 ans qui vient vous consulter avec ulcération endobuccale.

Cochez-moi les signes de malignité. Bord irrégulier et surélevé. Fond bourgeonnant.

Saignement au contact. Induration à la palpation. Si je mets disparaître au traitement, est-ce que c'est juste ou faux ? Une ulcération qui disparaît au traitement, est-ce qu'elle est malignée ? Non, bien sûr que non.

C'est faux en conséquence. Si je mets ne saigne pas au contact, c'est faux. Si je mets un fond qui est lisse, c'est faux.

Si je mets abords qui sont plats, c'est faux. Donc, une ulcération maligne, abords irréguliers, fond bourgeonnant, saignement au contact et induration à la palpation. Regardez-moi cette ulcération malignée qui en peut une partie de la lèvre.

C'est clair ? Oubliez-moi les ulcérations infectieuses. Ce n'est pas un problème parce que l'infectieuse, vous allez la traiter pendant une semaine. Si ça marche, d'accord, mais si ça ne marche pas, biopsiez et éliminez-moi un cancer.

C'est clair les étudiants ? Les lésions aussi fissuraires. Méfiez-vous des lésions fissuraires. Ces petites fissures sur le coin des lèvres, ces lésions fissuraires peuvent être un cancer, bien sûr.

Ce sont des ulcérations linéaires. Donc, il y a les perlèges, ce qui est classique, comme lésions infectieuses, mycosiques, surtout dans les condyloses, c'est connu. D'ailleurs, on remarque qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ça.

Et de toutes les façons, pour éliminer la condylose, on fait un prélèvement parasitologique et on élimine le diagnostic. Mais attention, attention au cancer. Donc, fissures avec induration, qui saignent au contact, c'est un cancer jusqu'à preuve du contraire.

Donc, il faut faire, bien sûr. Chez l'enfant, non, parce que chez l'enfant, souvent, c'est des mycoses. Mais si on fait le prélèvement muqueux et on ne trouve rien du tout, ça peut être aussi de la tumeur.

La tumeur, elle est plus rare chez l'enfant, mais elle peut exister. Donc, nous, on est vigilants. On n'élimine rien du tout.

Les lésions vésiculaires, donc au niveau de la face, au niveau de la cavité buccale, les lésions bulleuses. Voilà, les différents types de langues. On peut avoir une langue dépapillée.

On peut avoir une langue hyperpapillée. Regardez, il n'y a aucune papille. C'est une langue qui est lisse, atrophique.

C'est le cas des candidoses qui détruisent les bourgeons de goût. Et les langues hyperpapillées, les voilà, donc bouillonnées comme du velours. Et voilà, donc hyperpapillées.

On peut avoir aussi des langues plicaturées, donc une langue scrotale aussi. On peut avoir la macroglossie. Donc, les différentes anomalies de la langue dépapillées.

Un, deux, hyperpapillées, plicaturées et macroglossies. Donc, ne m'oubliez pas ces quatre anomalies de la langue. Langues dépapillées, hyperpapillées, plicaturées et macroglossies.

Est-ce clair, les étudiants? Bien, quelles sont les anomalies de la lèvre? Retenez-moi ce que vous voyez sur la photo. Qu'est-ce que vous voyez sur la photo? Qu'est-ce que vous voyez sur la photo? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Est-ce que c'est normal ce que vous voyez sur la photo? Non, ce n'est pas normal. C'est une discontinuité.

C'est congénitale, oui. Ça s'appelle fente. C'est une fente.

C'est une coupure. Fente labiale, unilatérale, incomplète. Fente labiale unilatérale, complète.

Fente labiale bilatérale et complète. C'est une fente labiale. Mais ici, comme l'a dit votre collègue, il y a la biopalatine.

La biopalatine. C'est une fente labiopalatine. Et d'ailleurs, on peut avoir... On va aller directement vers le palais.

Non, pardon, excusez-moi. Donc ici, si je mets cité des malformations labiales, parmi les malformations, la fente labiale. Est-ce que vous retenez ce terme? C'est ce qui s'appelle bec de lièvre.

Mais je n'aime pas ce terme, bec de lièvre. Ça fait ressembler l'être humain à un lièvre. C'est une fente labiale par défaut de coalescence des bourgeons faciaux, des bourgeons qui restent ouverts et qui restent sous forme de fente, qu'on opère et qu'on répare, des fois par des compagnies humanitaires.

Et nous, on a une association, SOS Face Marrakech, qui organise ces compagnies pour opérer les enfants malformés des fentes labiopalatines. Est-ce que vous avez retenu la fente labiale?

Très bien. Les autres malformations, on peut avoir une macroglossie.

Regardez-moi, macroglossie. Comme macroglossie, la même chose. Oui, le frein labial est aussi une malformation, bien sûr.

Est-ce que vos parents sont pédiatres? Baccalie? Non. OK. Bravo.

La duplication labiale. Il y a des gens qui ont double lèvre. Duplication labiale, regardez-moi ça.

Donc, parmi les malformations de la lèvre, il y a la fente labiale. Très bien. Donc, vous êtes loin du domaine.

Non, mais vous, vous êtes médecin. Ça, c'est super. Ah, d'accord.

Eh bien, je comprends maintenant. Donc, vous êtes un bébé du service. Très bien.

Donc, là, c'est une fente labiale. Là, c'est une macroglossie. Une lèvre qui est grande.

Et là, c'est une duplication labiale. Duplication labiale. Une lèvre qui est double.

Et ce sont des malformations qui se réparent. Ah, vous avez même fait des gardes. Super.

Ça fait plaisir. L'hypertrophie gingivale. Donc, les anomalies de la gingive.

On peut avoir une hypertrophie gingivale. La gingivite. La gingivoragie.

Donc, la gingivoragie, c'est l'hémorragie gingivale. Les fistules gingivales, les voilà. Et les tumeurs gingivales.

Les anomalies de palée. Donc, les anomalies de palée pour compléter le cours. On peut avoir les fentes palatines.

Donc, vous voyez, elle peut être uniquement une fente palatine. C'est un palais qui est divisé en deux. Sans une fente labiale.

Et on peut avoir une fente labiopalatine. Donc, parmi les anomalies, si on met la bio faciale, la fente labiopalatine, la fente palatine ou la fente labiale. Ou les deux.

Est-ce que c'est clair, les étudiants? Dites-moi, vous avez saisi? Est-ce que ça a été ce cours? Dites-moi, est-ce que vous avez le cours enregistré entier? Est-ce que vous avez tout le cours enregistré? Sonia me dit non. Est-ce qu'il y a une partie du cours qui n'est pas, juste le dernier cours? D'accord, je vais voir au niveau de l'administration pour arranger ça. Bien donc, mais vous avez le support du cours? Madame, on a le support, mais il n'est pas sonorisé.

Il n'y a pas une partie de sonorisé? Non, il y a des collègues qui disent le dernier cours. Et sonorisé, c'est la première partie. C'est la première partie.

Donc, vous avez le support du cours? Oui. Oui, on a le support. Vous avez le support.

D'accord, très bien. J'espère que vous avez profité de ce cours. Je vous souhaite bon courage à l'examen.

Et je crois que tout a été clair par cette interactivité, n'est-ce pas les étudiants? Il faut insister sur les parties les plus importantes. Donc, je vous souhaite bon courage et bonne réussite pour l'examen. Merci, Madame.

Et je vous souhaite, j'espère vous retrouver après dans le service pour vos stages hospitaliers et vous retrouver en cinquième année. Allez, bon appétit les étudiants. Merci beaucoup, Madame.

Merci, Madame.